



GUIA PARA PACIENTES

Dor lombar: o que fazer nas primeiras 72 horas

e quando procurar o médico

O que fazer nos 3 primeiros dias, quais sinais não dá para esperar e quais erros pioram a dor.



**DR. ROBERTO
RODRIGUES**
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CIRURGIA DO JOELHO

CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765 · @robertorodriguesmd

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Palavra-chave no Instagram: **LOMBAR**

Para quem é:

Para quem começou a sentir dor nas costas, na parte de baixo (região lombar), há poucos dias, **sem queda forte nem batida** e **sem nenhum dos sinais de alerta da próxima página**.

Para quem NÃO é:

- Quem tem algum sinal de alerta da Página 3.
- Quem já tem dor há mais de 6 semanas. Aí o assunto é outro e pede avaliação.
- Gestantes, quem operou a coluna há pouco tempo e quem tem osteoporose avançada: converse com seu médico antes de fazer os movimentos deste guia.

O que você vai precisar:

- Um colchonete ou tapete firme.
- Uma bolsa de água morna ou compressa térmica.
- Um travesseiro a mais.
- Este guia e uma caneta para o rastreador da Página 9.

Regra de ouro:

Movimento leve **sim**. Movimento que piora a dor e faz ela **descer pela perna, não**.

Se algum movimento faz isso, pare e pule para o próximo.

A maioria das dores lombares não é grave. Mas existe uma minoria que é, e ela tem sinais. **Leia esta página antes de qualquer outra.**

Procure um pronto-socorro HOJE se você tiver:

- **Perda do controle da urina ou das fezes**, ou dificuldade nova para urinar.
- **Dormência na região "da sela"**: entre as pernas, ao redor do ânus e dos genitais (onde você encostaria numa sela de bicicleta).
- **Fraqueza nas pernas que está piorando**: o pé "arrastando", tropeçar sem motivo, não conseguir ficar na ponta dos pés ou nos calcanhares.
- **Dor ou formigamento nas DUAS pernas** junto com os sinais acima.

Esses sinais podem indicar compressão grave dos nervos no fim da coluna (síndrome da cauda equina). É raro, mas é urgência: quanto antes for avaliado, melhor [1][10].

Procure avaliação médica em poucos dias (não espere as 72 horas) se:

- A dor começou depois de **queda, acidente ou trauma importante**, ou depois de um esforço pequeno em quem tem **osteoporose** ou usa **corticoide** há muito tempo.
- Você tem **febre**, calafrios, infecção recente, imunidade baixa ou usa drogas injetáveis.
- Você já teve **câncer**, mesmo que há anos.
- Você está **perdendo peso sem querer**.
- A dor **não alivia com nenhuma posição**, nem deitado, e é pior à noite.
- É a **primeira crise de dor lombar depois dos 50 anos**, principalmente se vier junto com algum item acima.

Uma observação honesta: nenhum desses sinais, sozinho, quer dizer doença grave. A maioria das pessoas com um deles não tem nada sério. Eles servem para dizer **quem precisa ser examinado antes**, e não para assustar [10].

Na maioria das crises, não há uma "peça quebrada"

Em quase todas as pessoas com dor lombar, **não é possível apontar uma única estrutura culpada**, nem com exame de imagem. Os médicos chamam isso de dor lombar inespecífica. O nome é feio, mas a notícia costuma ser boa: na maior parte das vezes, não é uma lesão grave [3].

O curso natural costuma ser favorável

Estudos que acompanharam milhares de pessoas mostram que a dor lombar aguda **costuma melhorar bastante nas primeiras 6 semanas**. Depois disso, a melhora fica mais lenta [9]. A diretriz do Colégio Americano de Médicos parte justamente desse ponto: a maioria melhora com o tempo [2].

Isso **não** quer dizer que todos melhoram, nem que a dor nunca volta. Crises repetidas são comuns [3].

O mito do repouso absoluto

Ficar dias na cama **não ajuda**. Quem é orientado a **se manter ativo** tem um pouco menos de dor e volta mais rápido às atividades do que quem é orientado a ficar deitado [5]. As diretrizes atuais recomendam continuar com as atividades normais, dentro do que a dor permite [1][4].

Ficar ativo não é "aguentar a dor". É fazer o que dá, um pouco por vez, sem forçar.

1. Mantenha-se em movimento

Levante, ande pela casa, faça as tarefas leves. Evite ficar mais de 30 a 40 minutos na mesma posição, sentado ou deitado. Esse intervalo é uma orientação prática, não um número estudado.

2. Calor local

O calor superficial (bolsa morna, compressa térmica) tem evidência de **alívio pequeno e de curta duração** na dor lombar aguda [2][6].

- 15 a 20 minutos, algumas vezes ao dia.
- **Sempre com um pano entre a bolsa e a pele.**
- **Nunca durma em cima de bolsa ou almofada térmica:** risco de queimadura.
- E o gelo? Ainda não há estudos suficientes para dizer se funciona na dor lombar [6]. Se você sente que ajuda, pode usar com o mesmo cuidado com a pele.

3. Caminhada leve

Comece com o que for confortável: às vezes são 5 minutos. Repita várias vezes no dia. Passos curtos, ritmo tranquilo, em terreno plano.

4. Volte ao trabalho assim que der

Se a sua atividade permite, voltar cedo, mesmo com ajustes, faz parte de se manter ativo [1][4].

Nenhuma posição é a "certa" para todo mundo. Use estas como ponto de partida e fique com a que aliviar **você**. São orientações práticas de consultório, não tratamentos testados em estudo.

Deitado de barriga para cima

Travesseiro **embaixo dos joelhos**, joelhos levemente dobrados.

Deitado de lado

Joelhos levemente dobrados e um travesseiro **entre os joelhos**.

Para levantar da cama ("rolar em bloco")

1. Deite de lado, virado para a beira da cama.
2. Coloque as pernas para fora da cama.
3. Ao mesmo tempo, empurre o colchão com as mãos e sente.
Faça o caminho inverso para deitar.

Sono

Dor atrapalha o sono, e sono ruim deixa a dor mais forte. Nos primeiros dias:

- Horário regular para deitar e acordar.
- Calor nas costas **antes** de deitar, e não durante a noite.
- Se acordar com dor, mude de posição devagar, usando o "rolar em bloco".

Antes de começar: estes movimentos não "curam" a coluna. Eles servem para **manter o movimento e reduzir a rigidez e o medo de se mexer**, que é o que as diretrizes recomendam [1][4]. Não existe prova de que um exercício específico seja melhor que outro na fase aguda [2]. Por isso escolhemos os mais suaves.

Regra: dor leve e estável é aceitável. Dor que aumenta ou desce pela perna: **pare**.

Movimento 1 — Respiração diafragmática (deitado)

Como fazer: deite de barriga para cima, joelhos dobrados e pés apoiados. Uma mão no peito e outra na barriga. Puxe o ar pelo nariz em 4 segundos, deixando a **barriga** subir. Solte pela boca em 6 segundos. Faça de 6 a 10 respirações.

Sensação correta: a barriga sobe e desce, o peito quase não mexe, e os músculos das costas vão "soltando".

Erro comum: subir os ombros e encher só o peito, ou prender a respiração.

Movimento 2 — Joelho ao peito, uma perna de cada vez

Como fazer: na mesma posição, segure atrás de um joelho e traga-o devagar em direção ao peito, **só até onde for confortável**. Fique 5 a 10 segundos e volte. Troque de perna. De 5 a 8 vezes de cada lado.

Sensação correta: um alongamento leve na parte de baixo das costas e no glúteo.

Erro comum: puxar com força ou trazer as duas pernas juntas logo no início. **Se a dor descer pela perna, pare este movimento.**

Movimento 3 — Gato-camelo suave (de quatro apoios)

Como fazer: apoie mãos e joelhos no chão (mãos embaixo dos ombros, joelhos embaixo do quadril). Arredonde as costas devagar, olhando para o umbigo. Depois deixe as costas voltarem e afundarem **um pouco**, olhando para a frente. De 6 a 10 vezes, bem devagar e acompanhando a respiração.

Sensação correta: a coluna "ondulando" sem dor aguda, com movimento pequeno.

Erro comum: forçar a amplitude, principalmente afundando demais as costas. Movimento pequeno já serve.

Sem conseguir ficar de quatro apoios? Faça a versão deitado: com os joelhos dobrados, encoste e desencoste levemente a lombar do chão, inclinando a pelve ("báscula pélvica").

Quantas vezes: 2 a 3 vezes ao dia, intercaladas com as caminhadas curtas.

Este guia não indica remédio nem dose. Quem decide é o seu médico, porque depende da sua idade, do seu estômago, dos seus rins, da sua pressão e dos remédios que você já usa. Remédio "comum" também tem risco.

O que as pesquisas e as diretrizes dizem, em termos gerais:

- **Primeiro, medidas sem remédio.** As diretrizes colocam informação, manter-se ativo e calor local como ponto de partida [1][2][4].
- **Paracetamol sozinho ajuda pouco ou nada** na dor lombar aguda, segundo um grande estudo com mais de 1.600 pessoas [7]. A diretriz inglesa (NICE) não recomenda paracetamol isolado para dor lombar [1].
- **Anti-inflamatórios e relaxantes musculares** podem ser considerados pelo médico, mas o efeito é pequeno e há efeitos colaterais [1][2].
- **Opioides** (remédios do grupo da morfina) **não são primeira escolha.** Um estudo recente com pessoas com dor lombar ou cervical aguda não mostrou alívio maior que o placebo e mostrou mais risco de uso indevido depois de um ano [8]. As diretrizes restringem o uso a casos específicos [1][2].
- **Injeção para dor nas costas** não é tratamento de rotina da crise aguda inespecífica.

Não use o remédio de outra pessoa nem repita uma receita antiga sem falar com o seu médico.

Dia 1 — Acalmar e se mexer

- Calor local 2 a 3 vezes (15 a 20 min, com pano).
- Caminhadas curtas, de 3 a 5 minutos, várias vezes ao dia.
- Movimentos 1 e 2, duas vezes.
- Levantar a cada 30 a 40 minutos sentado.
- Dormir na posição de alívio da Página 6.

Dia 2 — Ampliar com calma

- Calor local, se ajudar.
- Caminhadas de 5 a 10 minutos, várias vezes.
- Movimentos 1, 2 e 3, de duas a três vezes.
- Tarefas leves da casa e do trabalho, sem carregar peso.

Dia 3 — Voltar à rotina possível

- Caminhadas de 10 a 15 minutos, se a dor permitir.
- Movimentos 1, 2 e 3, de duas a três vezes.
- Retomar o máximo da rotina que der, com pausas.
- **Revisar a Página 3.** Algum sinal novo? Procure avaliação.

As durações são um ponto de partida prático. Ajuste ao seu corpo: o objetivo é progredir, não sofrer.

Rastreador

	Dor ao acordar (0–10)	Dor no fim do dia (0–10)	Caminhada total (min)	Sono (bom / médio / ruim)	Dor desceu pela perna? (S/N)
Dia 1					
Dia 2					
Dia 3					

0 = sem dor · 10 = a pior dor que você imagina.

Leve esta tabela para a consulta. Ela diz mais ao médico do que "doeu muito".

1. Ficar de cama "até passar".

O repouso prolongado não acelera a melhora e pode atrasar a volta à rotina [5].

2. Ter medo de qualquer movimento.

Dor nas costas não significa que a coluna está "se desgastando" a cada passo. Movimento leve e progressivo é parte do tratamento [1][4].

3. Exigir ressonância logo no primeiro dia.

Sem sinal de alerta, o exame de imagem na fase aguda raramente muda o tratamento e costuma mostrar alterações comuns, que também aparecem em quem não sente dor. As diretrizes não recomendam imagem de rotina nesses casos [1][4]. O exame é pedido quando vai mudar a conduta, e isso o médico avalia.

4. Se automedicar ou empilhar remédios.

Mais remédio não é mais alívio, e o risco aumenta (Página 8).

5. Forçar alongamento ou "estalar" a coluna sozinho no auge da dor.

Alongamento forte e manobras feitas em casa, no pico da crise, costumam piorar a proteção muscular. Na fase aguda, menos é mais (opinião clínica).

Procure avaliação médica se:

- A dor **não melhora de forma clara em cerca de 2 semanas**, ou **dura mais de 4 a 6 semanas**.
- A dor **desce pela perna, abaixo do joelho**.
- Surge **formigamento ou dormência** na perna ou no pé.
- A dor **está piorando** em vez de melhorar.
- As crises **se repetem** e estão atrapalhando o trabalho, o sono ou a vida.
- Você é jovem, tem **rigidez nas costas pela manhã que dura mais de meia hora** e melhora com o movimento. Esse padrão merece investigação.
- **A qualquer momento:** aparecer algum sinal da Página 3.

Os prazos acima são de bom senso clínico, coerentes com o curso natural descrito na Página 4 [9]. Não são uma regra rígida.

Se quiser uma avaliação

Na consulta, a avaliação é feita **com exame físico**: história, força, sensibilidade, reflexos e movimentos. Só depois disso se decide se há necessidade de exame e qual é o tratamento. Quando o caso pede um especialista em coluna, o encaminhamento faz parte do cuidado.

Agendamento: agendar.drrobertorodrigues.com

Instagram: @robertorodriguesmd

Atendimento em Fortaleza (CE).

Material educativo. Não substitui consulta médica. Nenhum tratamento tem resultado garantido. Cada caso precisa de avaliação individual.

1. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). **Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management**. NICE guideline NG59. Publicada em 30/11/2016; atualizada em 2020 e em 2026. Disponível em: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng59>
2. Qaseem A, Wilt TJ, McLean RM, Forciea MA; Clinical Guidelines Committee of the American College of Physicians. **Noninvasive treatments for acute, subacute, and chronic low back pain: a clinical practice guideline from the American College of Physicians**. Ann Intern Med. 2017;166(7):514-530. doi:10.7326/M16-2367. PMID: 28192789.
3. Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, et al; Lancet Low Back Pain Series Working Group. **What low back pain is and why we need to pay attention**. Lancet. 2018;391(10137):2356-2367. doi:10.1016/S0140-6736(18)30480-X. PMID: 29573870.
4. Foster NE, Anema JR, Cherkin D, et al; Lancet Low Back Pain Series Working Group. **Prevention and treatment of low back pain: evidence, challenges, and promising directions**. Lancet. 2018;391(10137):2368-2383. doi:10.1016/S0140-6736(18)30489-6. PMID: 29573872.
5. Dahm KT, Brurberg KG, Jamtvedt G, Hagen KB. **Advice to rest in bed versus advice to stay active for acute low-back pain and sciatica**. Cochrane Database Syst Rev. 2010;(6):CD007612. doi:10.1002/14651858.CD007612.pub2. PMID: 20556780.
6. French SD, Cameron M, Walker BF, Reggars JW, Esterman AJ. **Superficial heat or cold for low back pain**. Cochrane Database Syst Rev. 2006;(1):CD004750. doi:10.1002/14651858.CD004750.pub2. PMID: 16437495.
7. Williams CM, Maher CG, Latimer J, et al. **Efficacy of paracetamol for acute low-back pain: a double-blind, randomised controlled trial**. Lancet. 2014;384(9954):1586-1596. doi:10.1016/S0140-6736(14)60805-9. PMID: 25064594.
8. Jones CMP, Day RO, Koes BW, et al; OPAL Investigators Coordinators. **Opioid analgesia for acute low back pain and neck pain (the OPAL trial): a randomised placebo-controlled trial**. Lancet. 2023;402(10398):304-312. doi:10.1016/S0140-6736(23)00404-X. PMID: 37392748.
9. da C Menezes Costa L, Maher CG, Hancock MJ, McAuley JH, Herbert RD, Costa LO. **The prognosis of acute and persistent low-back pain: a meta-analysis**. CMAJ. 2012;184(11):E613-E624. PMID: 22586331.
10. Finucane LM, Downie A, Mercer C, et al. **International Framework for Red Flags for Potential Serious Spinal Pathologies**. J Orthop Sports Phys Ther. 2020;50(7):350-372. doi:10.2519/jospt.2020.9971. PMID: 32438853.

Material educativo. Não substitui consulta médica.

Dr. Roberto Rodrigues · CRM-CE 10806 · RQE 12256 · TEOT 17765

